

IMC = 33,96

MACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS 22231024703 | 859

LUIZ FELIPE CORDOBA DE FREITAS

IDADE: 43	PESO: 104	ALTURA: 175	PROFISSÃO: gerente de compra
SINTOMAS: Refluxo gástrico / dor de cabeça.			
QUEIXAS: Sonolência diurna / tontura / tontura / tontura			
MEDICAMENTOS: Horocur / clonidina-fluxotina / domitor / zeton / Depressão / HAS / Ácido Úrico / Haloperidol.			
MÉDICO: Dr. Pires -			
MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N			
EXERCÍCIO FÍSICO: não faz - caminhada			
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: — ALMOÇO: 12 LANCHE: 15 JANTAR: 19:30			
HORA QUE DORME: 22h		HORA QUE ACORDA: 6:30	
COCHILHO ☒ SIM () NÃO		DORME ACOMPANHADO ☒ SIM () NÃO () EVENTUAL	
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA () NÃO <i>às vezes</i>			
FUMO () SIM () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: <i>parou 15a.</i>			
TIPO DE RESPIRAÇÃO:		BANHEIRO: 2x	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP: <i>Assim</i> MALLAMPATI: IV		IAH: 62.3 efv SPO2: 72%	
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: <i>não</i>			
CIRURGIAS: (S) NASAL (M) AMIGDALECTOMIA <i>Desvio septo / adenóide</i>			
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: <i>Bronquite</i>			
COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA (M) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA			
(M) ORTOPÉDICA (M) NEUROLÓGICA () OUTROS			
18/03 <i>Md aus relata dificuldade p dormir.</i>			
24 <i>Atualização.</i>			
P = 9.2 cmH ₂ O			
25/03 IAH = 3.2 efv			
24 m. de uso: 7hr			
Fuga = 3.9 l/min			
05/04 P = 9.9			
24 IAH = 2.8 efv			
m. de uso: 6h 16'			
Fuga = 18.7			
26/04 P = 7.8 cmH ₂ O			
24 IAH = 2.6 efv			
m. de uso: 6hr			
14/06 P = 7.5 cmH ₂ O			
24 IAH = 3.2 efv			
m. de uso: 6h 40'			
21/02 P = 7.5			
24 IAH = 3.0			
m. de uso: 6hr			

Jua

Jua

Jua

Jua

Jua

Nome: LUIZ FELIPE CORDOBA DE FREITAS
Data de Nascimento: 29-1-1981
IMC: 33,96
Sexo: Masculino
Data do exame: 15-02-2023

Peso: 104 kg
Altura: 1,75 m
Médico: DR. GUILHERME SALOMON DE
DOMINICIS
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 15-02-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 562,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 85,0 e 146,5 minutos. O tempo total de sono foi de 434,5 min, eficiência de 77,2% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,4%; estágio N2: 65,4%; estágio N3: 13,7%; sono REM: 18,5%. O índice de despertares foi de 35,8/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 62,3/hora, sendo 81 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 159 hipopnéias. A SpO2 média foi de 90% e a mínima de 75%, permanecendo 21,8% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 48 - 89 bpm e NREM de 47 - 96 bpm.

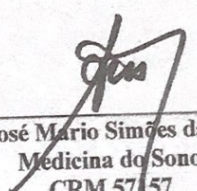
CONCLUSÃO: *Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (10), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:*

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 62,3/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=75%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157